EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 76361
SERVICIO : MEL MUJERES HSC
FECHA : 2023-12-26 11:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MAXIMILIANO MUNOZ URIBE			RUN	: 12.153.812-1
F.Nac	: 08-06-1969	Edad	: 54 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-12-06	Fecha Egreso	: 2023-12-26 11:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I82-OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EXTENSA
-VENA ILÍACA EXTERNA Y COMÚN IZQUIERDA CON TROMBO QUE SE INSINÚA HACIA LA VENA CAVA INFERIOR
2. TRAUMA PÉLVICO COMPLICADO
- FRACTURA DE SACRO 30.9.2023
- LESIÓN DE RECTO (COLOSTOMÍA)
3. INFECCIÓN HERIDA OPERATORIA SAMR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I82-OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. S32.1-FRACTURA DEL SACRO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. Z93.3-COLOSTOMIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. T79.3-INFECCION POSTRAUMATICA DE HERIDA, NO CLASIFICADA EN OTRA PA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente hospitalizado en Hodom por infeccion de heria operatoreia por SAMR. El dia 4/12/2023 inicia dolor en extrermidad inferior izquierda de forma aguda in crescendo asociado a aumento de volumken y cambios de coloracion. Consulta en urgencias por cuadro. Evaluado por cirugia y medicina interna donde debido a hallazgos sugerentes de isquemia aguda se inicia anticoagulacion y se solicitan examenes y posteriormente Angiotac. Se solicita evaluacion por UTI. AngioTC de Pelvis (06/12/2023): "Signos de trombosis de vena ilíaca externa y común izquierda con trombo que se insinúa hacia la vena cava inferior". Se realiza Ecocardioscopia (08/12/2023): cavidades no dilatadas, funcion sistolica biventricular conservada. Aparatos valvulares sin alteraciones significativas. Pericardio sin derrame. Vena cava inferior no dilatada sin evidencia de imágenes sugerentes de trombos en region proximal. Se inicia anticoagulación con BIC heparina… se decide omitir BIC de heparina considerando probable origen hemolitico de anemia como efecto secundario de heparina sodica asi como mas de 4 controles fuera de rango terapeutico a pesar de bolos y ajuste de BIC por peso. Se inicia anticoagulación con HBPM en dosis plena. Durante hospitalización paciente presenta infección herida operatoria SAMR, se inicia vancomicina. Se solicita ev por cx vascular sanatorio alemán quien refiere que dada la presencia de pulsos se descarta EAO, requiere continuar antociagulacion por 6 meses y Doppler control, soporte elástico antitrombo y reiniciar deambulación según indicación TMT. Se decide alta via hodom con knt motora para pierna derecha, seguimiento por cx y control poli taco.

INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM KNT MOTORA
2. REPOSO RELATIVO ASISTIDO
3. REGIMEN COMUN
4. KNT MOTORA EN PIERNA DERECHA POR 5 DIAS
5. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs.
6. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs
7. DABIGATRAN ETEXILATO 150 MG COMPRIMIDO UNIDAD 1 comprimido cada 12 hrs.
8. CONTROL POLI TACO EN 15 DIAS CON EXAMENES LABORATORIO FUNCION RENAL
9. CONTROL POLI CIRUGIA EN 20 DIAS

CAMILA COLLAO ITURRA
MEDICO TRATANTE
19088566-6

JEFE SERVICIO